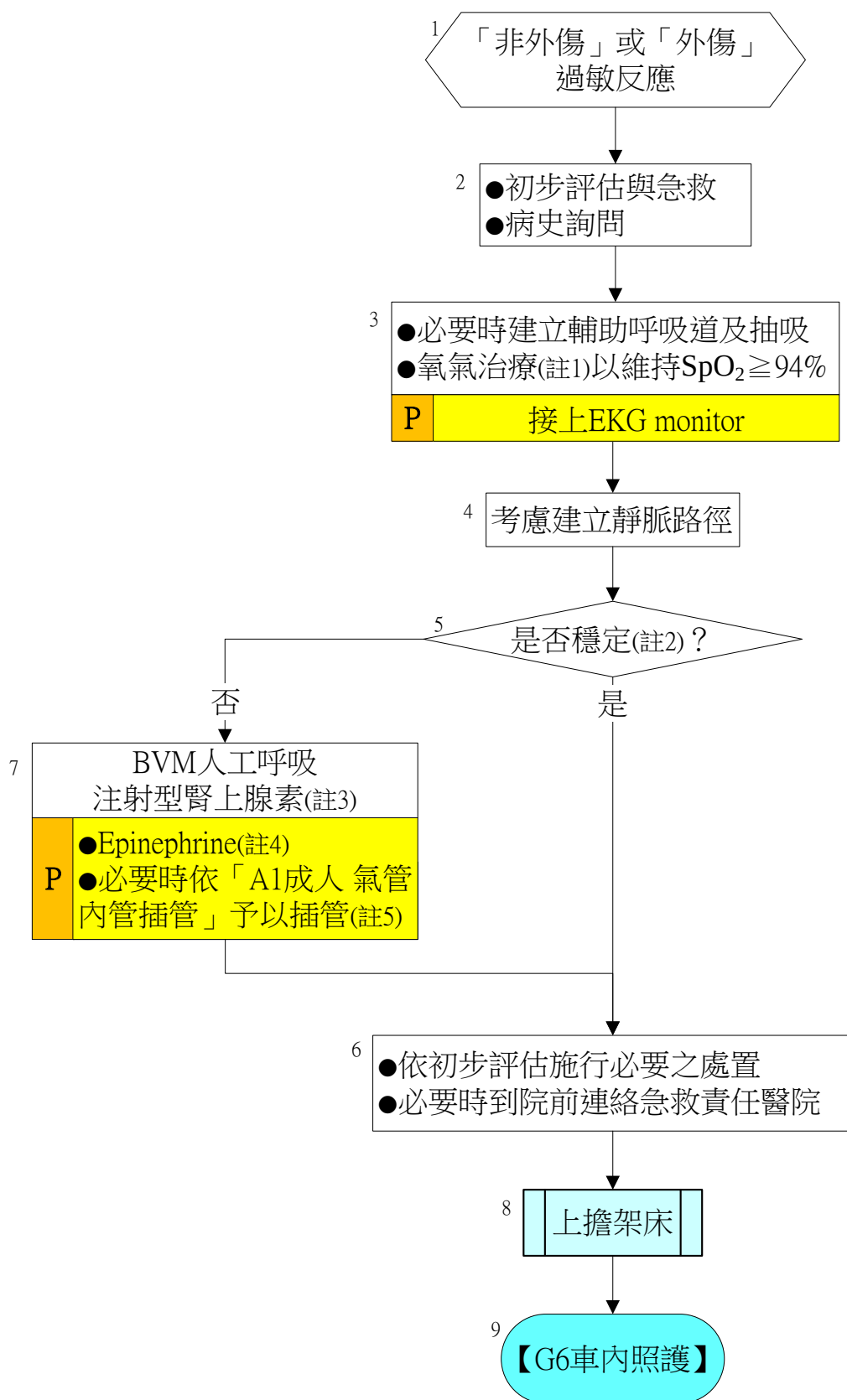


M5 過敏反應及過敏性休克

程 序



要 旨

- 一、主訴因食物、藥物、動物或植物作用導致過敏症狀（如噁心、嘔吐、喘、流鼻涕、流淚、腹瀉、腹痛、焦慮、頭暈、頭痛、暈厥、抽搐、昏迷、蕁麻疹或血管性水腫等）的病人，即建議使用本程序。
- 二、**過敏性休克**:因過敏而導致全身血管擴張導致血壓下降、咽喉水腫，而引發循環衰竭與呼吸衰竭，若不及時治療，將快速導致死亡。

註 解

註1>

給予高濃度的氧氣使 $SpO_2 \geq 94\%$ ，考慮使用純氧面罩（15公升/分）。

註2>

不穩定的病人：意識不清、皮膚濕冷、嚴重的呼吸窘迫、疑似上呼吸道阻塞（如呼吸道喘鳴音）或休克徵候(如收縮壓 <90 mm/Hg)。

註3>

若現場為山區郊外，有配置注射型腎上腺素之分隊，EMT2可於現場施打一次，並於到院後與醫護人員交接。

註4>

- 一、快速輸注生理食鹽水，可考慮2條大口徑靜脈管路輸液並予以加壓輸入。
- 二、**P** 考慮給予腎上腺素（1mg/1ml/1amp 之1:1000 製劑），若有使用，到院後EMTP應主動告知醫護人員；救護紀錄表應詳實記載，並交由醫療指導醫師核簽：
 - （一）成人與青少年：0.3 mg 肌肉注射。
 - （二）小兒：0.01 mg/kg （至多 0.3 mg） 肌肉注射。
 - （三）若註 2 之不穩定狀況持續存在，應確實紀錄並可以每 10 分鐘重覆一次上述劑量。

註5>

如果病人出現嚴重的呼吸窘迫，聯絡線上醫療指導，考慮施予氣管內管插入（依【A1 成人氣管內管插管】），並以袋瓣罩連接100 %的氧氣給予換氣。氣管內管的位置，必須利用Capnography確認。